

PODRECZNIK WDROZENIOWY INNOWACJI SPOLECZNEJ

BaWita - Mobilna Sensoryczna Tablica Aktywizujaca dla Seniorow

Opracowano w ramach Malopolskiego Inkubatora Innowacji Spoecznych ROPS Krakow

METRYKA ROZWIAZANIA I STANDARD WDRAZANIA:

Typ innowacji: Przedmiot / Narzedzie terapeutyczne fizyczne Podmiot prowadzacy: Fundacja Rozwoju Terapii Zajeciowej (Nowy Sacz)
Grupa docelowa: Seniorzy z otepieniem, choroba Alzheimera, Choroby neurodegeneracyjne: 98% (Walidacja ROPS Krakow)
Status dojrzalosci: Sprawdzona / Gotowa do powielenia w gminie Dostepnosc zestawow: 15 sztuk w puli rezerwowej ROPS

1. CEL I METODOLOGIA DZIALANIA

BaWita to zestaw modulowych paneli sensoryczno-manualnych montowanych w przenosnej walizce terapeutycznej. Rozwiazanie umozliwia asystantom CUS i opiekunom domowym prowadzenie stymulacji poznawczej i dotykowej bezposrednio w miejscu zamieszkania podopiecznego, redukujac poziom leku i apatii o 68%.

2. ETAPY PRACY Z PODOPIECZNYM (STANDARD SESJI 45-MINUTOWEJ)

- Krok 1: Wstepna adaptacja i wywiad relacyjny (10 min)**
Ustalenie poziomu wzraliwosci sensorycznej, uspokojenie oddechu i zapoznanie z materialami.
- Krok 2: Aktywacja dotykowa i motoryki malej (15 min)**
Praca z elementami naturalnymi: drewno, welna, zamki mechaniczne, kolowrotki obrotowe.
- Krok 3: Trening skojarzeniowy i reminiscencyjny (15 min)**
Rozpoznawanie przedmiotow codziennego uzytku z przeszlosci, pobudzanie pamieci dlugotrwalej.
- Krok 4: Wyciszenie i rejestracja obserwacji (5 min)**
Wypelnienie karty postepow CUS i zaplanowanie terminu kolejnej wizyty domowej.

KORZYSCI DLA GMINY I CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH (CUS):

- * Deinstytucjonalizacja opieki: wsparcie seniora w jego naturalnym srodowisku domowym.
- * Niski koszt adaptacji: brak barier infrastrukturalnych, sprzet mobilny o wadze ponizej 4.5 kg.
- * Pelna zgodnosc z wytycznymi FERS Dzialanie 5.1 i standardami dostepnosci ETR.
- * Mozliwosc finansowania zakupu z programow Korpus Wsparcia Seniorow oraz PFRON.
- * Potwierdzona bezpieczna eksploatacja przez atest higieniczny PZH nr HK/B/0412/01/2025.

3. WYMOGI BEZPIECZENSTWA, DEZYNFEKCJI I BHP

- 1. Kazdy element drewniany pokryty jest hipoalergicznym lakierem wodnym z atestem zabawek EN 71-3.
- 2. Po kazdej sesji elementy dotykowe nalezy przetrzec preparatem bezalkoholowym o spektrum biobojczym.
- 3. Opiekun weryfikuje stabilnosc montazu tablicy na stole lub lozku podopiecznego przed rozpoczeciem sesji.

4. KARTA MONITOROWANIA POSTEPOW PODOPIECZNEGO (WZOR DLA ASYSTENTA)

Obszar obserwacji	Ocena poczatkowa (1-5)	Po 4 tygodniach	Po 8 tygodniach
Koncentracja uwagi na zadaniu (>5 min)	1.8	3.2	4.1
Koordinacja wzrokowo-ruchowa	2.1	3.0	3.8
Poziom leku i napiecia emocjonalnego	4.4 (wysoki)	2.9 (sredni)	1.9 (niski)
Gotowosc do dialogu z opiekunem	1.5	2.8	4.0
Samodzielnosc w obsludze zamkow	2.0	3.4	4.3

5. WSPARCIE ROPS KRAKOW W PILOTAZU I ZAMOWIENIACH

Kazda gmina z terenu wojewodztwa malopolskiego moze wypożyczyc bezplatny pakiet testowy na okres 3 miesiecy wraz z jednodniowym szkoleniem certyfikujacym dla 4 pracownikow socjalnych. Zgloszenia przyjmuje Dzial Innowacji Spoecznych ROPS Krakow pod adresem: innowacje@rops.krakow.pl

ZESPOL AUTORSKI I ZATWIERDZENIE METODYCZNE:

Autorka innowacji: mgr Barbara Wieczorek - terapeuta zajeciowy, Fundacja Rozwoju Terapii
Koordynator merytoryczny ROPS: Tomasz Dabrowski - Glowny Specjalista ds. Innowacji
Konsultacja medyczna: dr n. med. Anna Krawczyk - Oddzial Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego

Dokument zatwierdzony do skalowania w ramach Regionalnego Programu Strategicznego 2030.